

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE VICTIMIZACIÓN JUVENIL (JVQ)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Integral de Violencia Infanto-Juvenil y Polivictimización

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Victimización Juvenil (JVQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ)</i>
Autores Originales	David Finkelhor, Sherry L. Hamby, Richard Ormrod y Heather A. Turner (2005), University of New Hampshire.
Adaptaciones Españolas	Noemí Pereda, Georgina Guilera, Maria Forns y Juana Gómez-Benito (2010, Child Abuse & Neglect); Pereda et al. (2014).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación psicosocial, forense y clínica del trauma infantil.
Tipo de Instrumento	Entrevista estructurada o autoinforme de 34 reactivos dicotómicos (Sí/No) con preguntas de seguimiento cualitativo.
Población y Rango	Niños, adolescentes y jóvenes (8 a 18 años). Servicios de protección, justicia juvenil, clínica y colegios.
Tiempo de Administración	15 a 25 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto institucional (Crimes Against Children Research Center, CCRC) para uso forense y clínico no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y EL PARADIGMA DE POLIVICTIMIZACIÓN

El JVQ fue concebido por David Finkelhor y colaboradores (2005) para subsanar la fragmentación de la investigación criminológica y clínica sobre violencia infantil, la cual tradicionalmente estudiaba de forma aislada el acoso escolar, el maltrato físico o el abuso sexual. El JVQ integra en una matriz comprensiva los múltiples tipos de victimización a los que puede verse expuesto un menor.

El constructo central articulado por el JVQ es la **Polivictimización**: la condición de los niños y adolescentes que sufren no una sola forma de agresión, sino múltiples tipos cualitativamente distintos de violencia en diferentes contextos ecológicos (hogar, escuela, comunidad y entorno digital). La evidencia empírica demuestra que el impacto psicológico traumático (depresión severa, TEPT complejo, conductas autolesivas) no depende tanto de la frecuencia de un único delito, sino de la acumulación polivictimizadora que destruye los entornos de seguridad del menor.

3. LOS CINCO MÓDULOS DE VICTIMIZACIÓN DEL JVQ (FINKELHOR ET AL., 2005)

Módulo de Victimización	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Tipología Delictiva
1. Delitos Comunes	1 al 9	0 a 9	Robos con fuerza, hurtos, agresiones físicas simples o con armas, vandalismo e intentos de secuestro.
2. Maltrato Infantil	10 al 14	0 a 5	Abuso físico parental o por cuidadores, castigos desproporcionados, negligencia física y abandono emocional.
3. Iguales y Hermanos	15 al 20	0 a 6	Acoso escolar continuo (<i>bullying</i>), agresiones físicas por compañeros de clase y violencia física entre hermanos.
4. Victimización Sexual	21 al 26	0 a 6	Tocamientos no deseados, agresión sexual con penetración, exhibicionismo y acoso sexual verbal/digital.
5. Testigo / Indirecta	27 al 34	0 a 8	Presenciar violencia de género intrafamiliar, tiroteos, apuñalamientos callejeros, guerras y agresiones a padres.
TOTAL VICTIMIZACIONES	1 al 34	0 a 34	Conteo total de formas distintas de victimización experimentadas.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia y Validez	Excelente validez de constructo y fiabilidad test-retest $r = 0.81$ en la adaptación española de Pereda et al. (2010, 2014) en muestras comunitarias y de justicia juvenil.
Poder Predictivo	La polivictimización evaluada con el JVQ explica más del 40% de la varianza en sintomatología de estrés postraumático (Trauma Symptom Checklist - TSCC) y desregulación emocional.
Validez Concurrente	Elevada correlación con escalas de conducta internalizante y externalizante del CBCL ($r = 0.65$) y con cuestionarios de sintomatología disociativa juvenil.
Invarianza de Medida	Estructura modular replicada en diferentes contextos socioeconómicos y grupos de edad en España y Latinoamérica.
Sensibilidad Forense	Herramienta de elección en peritajes forenses judiciales para determinar la cronología y extensión del daño victimológico acumulativo.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada una de las 34 formas de victimización se indaga de forma dicotómica:

- **0 = NO** (no ha ocurrido en el período evaluado) | **1 = SÍ** (ha ocurrido al menos una vez).
- **Marco Temporal Doble:** Puede aplicarse evaluando el **último año** (victimización reciente) y/o **a lo largo de la vida** (victimización acumulada histórica).
- **Puntuación Total de Victimización:** Suma de reactivos afirmativos (Rango: **0 a 34 puntos**).

Puntuación Total = Suma de ítems afirmativos (0 a 34) | Módulos independientes 1 al 5

6. BAREMOS Y UMBRAL DE POLIVICTIMIZACIÓN (PEREDA ET AL., 2010; FINKELHOR, 2005)

Condición	Puntos (Año)	Estado Victimológico	Conducta Asistencial / Judicial Recomendada
No Victimizado	0	Ausencia de victimización	Entorno seguro. Acciones preventivas escolares habituales.
Victimizado Leve	1 a 2	Victimización aislada / Común	Episodios comunes de conflicto entre iguales. Apoyo escolar y familiar básico.
Victimizado Medio	3 a 4	Victimización múltiple moderada	Vulnerabilidad psicosocial notable. Intervención orientadora y seguimiento escolar.
Polivictimización	≥ 5 ($\geq P90$)	Condición Crítica de Polivíctima	Colapso de entornos de protección. Activación urgente de Servicios Sociales y Salud Mental.

EL UMBRAL DEL PERCENTIL 90 EN ESPAÑA: En población española (Pereda et al., 2010), el umbral para considerar a un adolescente formalmente como **Polivíctima** se sitúa en *ge5* tipos distintos de victimización en el último año (o *ge9* a lo largo de la vida), concentrando más del 70% de la patología psiquiátrica grave en menores.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y PROTECCIÓN AL MENOR

ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR ANTE POLIVICTIMIZACIÓN:

- **Paso 1 (Salvaguarda Inmediata):** Si se confirma maltrato intrafamiliar (Módulo 2) o abuso sexual (Módulo 4), el deber ético y legal prioritario es garantizar la seguridad física del menor notificando a la Fiscalía de Menores y Servicios Sociales de Protección a la Infancia.
- **Paso 2 (Abordaje del Trauma Complejo):** Los menores polivictimizados no responden a terapias breves de exposición simple; requieren un modelo de fases (Herman, Cloitre): Fase 1 de seguridad y estabilización vincular, Fase 2 de procesamiento del trauma (EMDR / TF-CBT) y Fase 3 de reintegración social.
- **Paso 3 (Coordinación Escolar):** Implementar protocolos de protección activa antibullying en el centro educativo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: MENOR POLIVICTIMIZADO EN CENTRO DE ACOGIDA

Paciente: Chica de 14 años, derivada por el equipo de infancia de servicios sociales tras fuga reiterada del domicilio, autolesiones en brazos y sospecha de agresión sexual grupal.

Resultados JVQ:

- **Puntuación Total en el último año: 8/34 victimizaciones distintas (Condición de Polivíctima Severa — > P95).**
- **Desglose por módulos:** Módulo 2 (Maltrato): castigo físico severo y negligencia por parte del padrastro; Módulo 3 (Iguales): acoso escolar continuado con palizas grabadas en vídeo; Módulo 4 (Sexual): agresión sexual con penetración por conocidos de su barrio; Módulo 5 (Testigo): presenciar habitualmente violencia de género hacia su madre.

Conducta Asistencial: Se declara situación de desamparo y se decreta el ingreso en un centro de protección de menores con medidas residenciales de seguridad. Se inicia atención psicoterapéutica especializada en trauma complejo infanto-juvenil (TF-CBT) y se remite el informe pericial al Juzgado de Instrucción. A los 9 meses de intervención intensiva, la menor cesa completamente las autolesiones y restablece la escolarización reglada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y OBLIGACIÓN LEGAL DE COMUNICACIÓN

ALERTA: DEBER LEGAL DE NOTIFICACIÓN

En España (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, LOPVI), cualquier revelación en el JVQ de abuso sexual o maltrato activo obliga al profesional a comunicar el hecho judicialmente.

ALTO RIESGO DE SUICIDIO

Los menores polivictimizados presentan un riesgo 8 veces superior de tentativa de suicidio respecto a sus iguales; es preceptivo realizar cribado de seguridad autolítica inmediato (C-SSRS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Finkelhor, D., Hamby, S. L., Ormrod, R., & Turner, H. A. (2005). The Juvenile Victimization Questionnaire: reliability, validity, and national norms. *Child Abuse & Neglect*, 29(4), 383–412.
2. Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2010). The Juvenile Victimization Questionnaire: Psychometric properties and poly-victimization in a Spanish adolescent sample. *Child Abuse & Neglect*, 34(10), 748–755.
3. Pereda, N., Guilera, G., & Abad, J. (2014). Victimización y polivictimización en una muestra de menores en protección y reforma. *Anuario de Psicología Jurídica*, 24(1), 33–38.
4. Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. *Child Abuse & Neglect*, 31(1), 7–26.